

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 内分泌療法・CDK4/6阻害薬の服用日・休薬日・残薬の管理
- ☐ 他院の抗うつ薬・抗菌薬・市販薬・サブリの相互作用確認
- ☐ 関節痛・ほてりなど継続の妨げになる症状の聴取と対処
- ☐ 電話フォローで下痢(アベマシクリブ)・発熱を確認
- ☐ 骨密度検査・歯科受診の状況を確認し、病院へ情報提供

病院薬剤師

- ☐ サブタイプ・閉経状況とレジメンの整合性の監査
- ☐ アントラサイクリン累積量・心エコー予定の管理
- ☐ 化学療法の制吐薬・G-CSFの設定、導入時の説明
- ☐ T-DXdのILD、CDK4/6阻害薬の血液検査への対応
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・治療目的の記載

病院と共有する情報

サブタイプ・治療目的

検査値

下痢・関節痛のGrade

服用状況・残薬

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

レジメン・薬剤	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
AC/EC→タキサン	ドキシソルビン(エビルビン)+シクロホスファミド →パクリタキセル毎週 または ドセタキセル	2～3週毎	高度催吐性の制吐薬、脱毛、アントラサイクリンの累積投与量
タモキシフェン	20mg 1日1回 連日内服(5～10年)	連日	CYP2D6阻害薬(パロキセチン等)、ほてり、不正性器出血・下肢の腫れ
アロマターゼ阻害薬	アナストロゾール/レトロゾール/エキセメスタン 1日1回	連日	関節痛・こわばり、骨密度検査・骨粗鬆症治療薬
パルボシクリブ	125mg 1日1回 21日服用・7日休薬(内分泌療法と併用)	4週毎	好中球減少(服用前の血液検査)、服用日と休薬日、CYP3A阻害薬
アベマシクリブ	150mg 1日2回 連日内服(内分泌療法と併用)	連日	開始早期の下痢(止瀉薬を携帯)、肝機能、静脈血栓塞栓症
T-DXd	点滴(HER2陽性・HER2低発現)	3週毎	咳・息切れ・発熱(ILD)、悪心・嘔吐への制吐薬

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意	タモキシフェン CYP2D6阻害(活性化↓)	処方薬 パロキセチン等の・強いCYP2D6阻害薬	活性代謝物↓ → 効果減弱のおそれ	他院の抗うつ薬の処方を確認
注意	パルボシクリブ・アベマシクリブ CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑ → 好中球減少・下痢↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意	CDK4/6阻害薬 CYP3A4阻害・誘導	サブリ・食品 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	副作用↑・効果↓	食品・サブリの摂取を聴取
注意	内分泌療法 作用の拮抗	処方薬 エストロゲン製剤(ホルモン補充療法等)	内分泌療法の効果減弱	婦人科など他院の処方を確認
注意	トラスツズマブ・アントラサイクリン 心毒性の重複	既往・疾患 心疾患の既往・胸部放射線の治療歴	心機能低下↑	息切れ・むくみを聴取し病院へ共有
確認	デノスマブ・ビスホスホネート 顎骨壊死のリスク	処置・検査 抜歯などの歯科治療	顎骨壊死	歯科受診時に服用を伝えるよう指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「この治療は年単位で続きます。飲み忘れを防ぐため、お薬カレンダーや服用時間を一緒に決めましょう」

確認:お薬手帳でサブタイプ・治療目的、併用薬(CYP2D6・CYP3A4関連、市販薬)
 △パロキセチン等はタモキシフェンの効果を弱めるおそれ

CDK4/6開始期

「下痢が出たら、お渡しした下痢止めをすぐに飲み、水分を多めにとってください」

確認:電話フォローで下痢の回数と止瀉薬の使い方を確認
 △止瀉薬で24時間以内に改善しない時は連絡

化学療法1～2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローでnadir期の発熱・口内炎を確認
 △発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

長期服用中

「関節のこわばりやほてりは、つらければ対処法があります。我慢せずに教えてください」

確認:内分泌療法の継続状況・残薬、関節痛・ほてりの程度
 △息切れ・むくみ・咳が続く時は早めに受診